

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

2^{da.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 858

17 de noviembre de 2025

Presentado por señor Ríos Santiago

Referido a la Comisión de Salud

LEY

Para enmendar el Artículo 1.02, añadir nuevos incisos (k-1), (u-1), (u-2), (aa-1), (dd-1), (dd-2) y (nn-1) al Artículo 1.03, añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 5.04, añadir un nuevo Artículo 11-A, enmendar el Artículo 5.16 y añadir un nuevo Artículo 5.18 de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como Ley de Farmacia de Puerto Rico, a los fines de establecer un marco regulatorio para los medicamentos compuestos de alto riesgo y las farmacias no residentes que permita la responsable protección salubrista de los pacientes localizados en Puerto Rico; establecer la “Ley para la Supervisión sobre Medicamentos Compuestos de Alto Riesgo”; requerir la publicación de informes bianuales por parte de la la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARPS) junto con la Oficina de Planificación y Desarrollo Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAPS), y la Junta Examinadora de Farmacia sobre la supervisión de las prácticas de preparación de medicamentos compuestos; garantizar una mayor visibilidad sobre las acciones regulatorias para proteger a los pacientes de medicamentos preparados ilegalmente; y otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La preparación ilegal de medicamentos compuestos representa un desafío creciente y de gran magnitud en Puerto Rico, que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y la integridad del sistema de salud. Los ciudadanos merecen medicamentos en los que puedan confiar, que sean seguros, efectivos y elaborados conforme a los más

altos estándares de calidad establecidos por las regulaciones estatales y federales. Sin embargo, en los últimos años, se ha observado un aumento alarmante en la distribución de medicamentos compuestos sin la supervisión adecuada, lo que constituye una amenaza significativa para la salud pública. Este problema es particularmente pronunciado en el caso de los medicamentos GLP-1 utilizados para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, aunque se extiende a otras clases de medicamentos, afectando a diversos sectores de la población.

La preparación de medicamentos compuestos, cuando se realiza conforme a las normativas, es una práctica esencial que permite adaptar tratamientos a las necesidades específicas de los pacientes. No obstante, la proliferación de actividades de preparación ilegal, especialmente en entornos no regulados como spas médicos y clínicas de bienestar, ha ~~generado~~ evidenciado un vacío regulatorio que trasciende la mera supervisión del establecimiento físico o del profesional que realiza el procedimiento. El problema salubrista no radica únicamente en la práctica estética, sino en el manejo y administración de medicamentos compuestos cuya naturaleza requiere controles y supervisión especializada. Cuando estos productos son preparados sin receta individual previa, adquiridos como ingredientes farmacéuticos activos sin adecuada trazabilidad, o prescritos mediante evaluaciones insuficientes, se desdibuja la línea entre la composición farmacéutica legítima y la manufactura no regulada. Ello coloca al paciente en una posición de vulnerabilidad y dificulta la intervención temprana del Estado ante eventos adversos o prácticas negligentes. ~~en la supervisión de los entes reguladores.~~ Estos establecimientos, que a menudo operan sin la fiscalización de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública ~~Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud~~ (en adelante, SARPSS~~SARAFS~~) y la Junta Examinadora de Farmacia en materia de medicamentos, representan puntos ciegos regulatorios. Los actores malintencionados aprovechan estas lagunas legales y de cumplimiento para producir y comercializar medicamentos no aprobados a una escala sin precedentes, exponiendo a los pacientes a riesgos graves, como la administración de productos ineficaces, contaminados o potencialmente peligrosos.

A esta realidad se suma el aumento en la dispensación y envío de medicamentos compuestos hacia Puerto Rico por parte de farmacias ubicadas fuera de la jurisdicción, comúnmente denominadas farmacias no residentes. Si bien estas entidades pueden estar autorizadas en sus estados de origen, su operación hacia pacientes en Puerto Rico plantea retos particulares de fiscalización, acceso a información regulatoria y capacidad de respuesta ante eventos adversos o incumplimientos. La ausencia histórica de un mecanismo uniforme de registro y supervisión local ha limitado la visibilidad de las autoridades regulatorias sobre el volumen, naturaleza y riesgos asociados a medicamentos compuestos que ingresan a la jurisdicción desde el exterior, especialmente aquellos clasificados como de alto riesgo.

A lo anterior se añade la limitada disponibilidad de información pública y legislativa sobre las acciones de fiscalización que realizan las entidades reguladoras para atender esta problemática. Actualmente, no existe un mecanismo sistemático de recopilación y divulgación que permita conocer, entre otros aspectos, el número de farmacias residentes y no residentes que preparan o dispensan medicamentos compuestos para pacientes localizados en Puerto Rico, las inspecciones efectuadas, la naturaleza de las violaciones detectadas, las investigaciones iniciadas ni las medidas correctivas o disciplinarias impuestas. Esta insuficiencia de datos dificulta la evaluación objetiva de la efectividad del marco regulatorio vigente y limita la capacidad del Estado para asignar recursos y diseñar estrategias basadas en evidencia que fortalezcan la protección de los pacientes.

~~La falta de transparencia sobre las acciones que los reguladores están tomando para abordar este problema agrava la situación. Actualmente, tanto los legisladores como el público general carecen de información clara y detallada sobre las medidas adoptadas por SARAFS y la Junta Examinadora de Farmacia para garantizar que la preparación de medicamentos se realice de manera segura y legal. Esta opacidad dificulta la evaluación de la efectividad de las políticas existentes y la identificación de las áreas donde se necesitan recursos adicionales o reformas regulatorias. Por ejemplo, no se conoce con precisión el número de inspecciones realizadas a instalaciones que manejan medicamentos preparados, ni la naturaleza de las violaciones detectadas, ni las acciones disciplinarias tomadas contra los infractores. Esta falta de datos también limita la~~

capacidad de los responsables de crear políticas para diseñar estrategias que protejan eficazmente a los pacientes.

Además, el aumento en la comercialización de medicamentos preparados a través de prácticas engañosas, como la publicidad indebida en plataformas de telemedicina o telesalud, añade otra capa de complejidad al problema. Estas prácticas no solo confunden a los consumidores, sino que también socavan la confianza en el sistema de salud y en los profesionales que operan dentro de los marcos regulatorios establecidos. La ausencia de una coordinación efectiva entre las juntas reguladoras y otras agencias estatales, contribuye a la persistencia de estas actividades ilícitas.

Esta Ley busca abordar estas deficiencias al establecer un mecanismo robusto de rendición de cuentas y transparencia. Mediante la exigencia de informes bianuales, se proporcionará a los legisladores, reguladores y al público una visión clara de las actividades de supervisión relacionadas con la preparación de medicamentos. Estos informes incluirán datos críticos sobre licencias emitidas, inspecciones realizadas, investigaciones abiertas, acciones disciplinarias tomadas y riesgos emergentes. Al hacerlo, la Ley no solo promoverá una mayor visibilidad sobre las acciones regulatorias, sino que también permitirá identificar las necesidades de recursos humanos y materiales de las juntas reguladoras, garantizando que estén adecuadamente equipadas para enfrentar los desafíos de la preparación de medicamentos de alto riesgo.

Por todo lo cual, resulta imperativo enmendar la Ley de Farmacia de Puerto Rico para establecer un marco legal abarcador que regule y supervise específicamente los medicamentos compuestos de alto riesgo, independientemente del entorno en que se administren. Una legislación integral debe definir con claridad estos medicamentos, imponer requisitos de receta individualizada, asegurar la trazabilidad de los ingredientes activos, exigir notificación de eventos adversos y facultar a las autoridades sanitarias para fiscalizar su preparación y dispensación. Solo mediante un régimen normativo coherente y robusto podrá el Estado cumplir con su deber indelegable de proteger la salud pública, garantizar la seguridad del paciente y prevenir que

prácticas comerciales emergentes comprometan estándares básicos de calidad y responsabilidad sanitaria.

Ante este escenario, esta Ley enmienda la Ley de Farmacias de Puerto Rico para establecer un marco robusto de transparencia, registro y rendición de cuentas en la supervisión de la preparación y dispensación de medicamentos compuestos, particularmente aquellos clasificados como de alto riesgo. Como componente esencial, se dispone el requisito de registro de farmacias no residentes que envíen, dispensen o distribuyan medicamentos compuestos a pacientes en Puerto Rico, con el propósito de permitir a las autoridades regulatorias identificar, evaluar y supervisar de manera más efectiva estas operaciones extraterritoriales con impacto directo en la salud pública local. Dicho registro facilitará el acceso a información sobre licencias vigentes, historial disciplinario, cumplimiento con estándares federales aplicables y volumen de operaciones hacia la jurisdicción, fortaleciendo la capacidad de vigilancia y respuesta regulatoria.

Mediante la implantación de requisitos de informes periódicos, se proveerá a la Asamblea Legislativa, a las entidades reguladoras y al público información clara y estandarizada sobre las actividades de licenciamiento, registro, inspección, investigación y disciplina relacionadas con establecimientos residentes y no residentes que manejen medicamentos compuestos. Estos informes permitirán identificar tendencias, riesgos emergentes y necesidades de recursos humanos y materiales, fortaleciendo la capacidad institucional de fiscalización.

En última instancia, esta legislación tiene como objetivo fortalecer la protección de los pacientes puertorriqueños, asegurando que los medicamentos que reciben sean seguros, efectivos y elaborados bajo estrictos estándares de calidad. Al ~~fomentar~~ promover una supervisión más efectiva, ~~y~~ coordinada y transparente entre la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP), ~~incluyendo supervisión de farmacias no residentes~~ Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud y la Junta Examinadora de Farmacia, esta Ley ~~representa~~ constituye un paso esencial para mitigar ~~crucial hacia la mitigación de los riesgos asociados a con la preparación ilegal de medicamentos y la restauración de para preservar~~ la confianza pública en el sistema de salud.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1.02 de la Ley 247-2004, según enmendada,
2 conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

3 “Artículo 1.02. – Propósito.

4 El propósito de esta Ley es promover, preservar y proteger la salud, la
5 seguridad y el bienestar público mediante el control y reglamentación efectivo de la
6 práctica de farmacia y el licenciamiento, control y reglamentación de los
7 establecimientos y personas que manufacturan, distribuyen, dispensan y expenden
8 medicamentos y artefactos que se utilizan en el diagnóstico, tratamiento y prevención
9 de enfermedades a pacientes localizados en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
10 independientemente del lugar físico donde se origine el despacho. Esta Ley no regula o afecta
11 de modo alguno lo referente al mercadeo de medicamentos por correo desde los
12 Estados Unidos o el extranjero a la jurisdicción territorial del Estado Libre Asociado
13 de Puerto Rico.”

14 Artículo 1.- Título

15 Esta Ley se conocerá como la “Ley para la Supervisión sobre Medicamentos
16 Compuestos de Alto Riesgo”.

17 Sección 2. - Se añaden los nuevos incisos (k-1), (u-1), (u-2), (aa-1), (dd-1) (dd-2) y (nn-
18 1) al Artículo 1.03 de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de
19 Puerto Rico”, para que lea como sigue:

20 “Artículo 1.03. – Definiciones.

21 A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado
22 que a continuación se indica:

1 (a) ...

2 ...

3 (k) ...

4 (k-1) Dispensación a paciente localizado en Puerto Rico – La dispensación o despacho
5 que ocurre cuando el paciente, prescribiente o dirección de entrega se encuentre en Puerto Rico
6 independientemente si parte del proceso de dispensación ocurrió fuera de Puerto Rico.

7 (l) ...

8 ...

9 (u) ...

10 (u-1) Evento Adverso - cualquier acontecimiento o suceso medico desfavorable asociado
11 con el uso de un medicamento en seres humanos, independientemente de que se considere o no
12 relacionado causalmente con dicho medicamento.

13 (u-2) Evento Adverso Grave - un evento adverso que resulte en cualquiera de los
14 siguientes resultados: muerte, una experiencia que ponga en peligro la vida, hospitalización de
15 un paciente; una incapacidad o discapacidad persistente o significativa, una anomalía
16 congénita o defecto de nacimiento, o un evento que requiera, según el juicio médico razonable,
17 una intervención médica o quirúrgica para prevenir alguno de los resultados antes descritos.

18 (v) ...

19 (aa) ...

20 (aa-1) Farmacia no residente – Establecimiento de servicio de salud dedicados a la
21 prestación de servicios farmacéuticos, que incluye: la dispensación de medicamentos de receta,
22 medicamentos sin receta, artefactos y otros productos relacionados con la salud, la prestación

1 de cuidado farmacéutico y otros servicios dentro de las funciones del farmacéutico establecidas
2 en esta ley, incluyendo pero sin limitarse a instalaciones 503A o 503B, localizado fuera de
3 Puerto Rico que ejerza dispensación a paciente localizado en Puerto Rico por correo, mensajería,
4 telemedicina o cualquier otro método remoto.

5 (bb) ...

6 ...

7 (dd) ...

8 (dd-1) Ingrediente farmacéutico activo - toda sustancia destinada a incorporarse en un
9 medicamento terminado y que tenga por objeto proporcionar actividad farmacológica u otro
10 efecto directo en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades, o
11 afectar la estructura o cualquier función del organismo humano. El término no incluirá los
12 intermediarios utilizados en la síntesis de dicha sustancia ni los ingredientes inactivos del
13 medicamento, tales como agentes saborizantes o excipientes.

14 (dd-2) Facilidad que fabrica un ingrediente farmacéutico activo - el establecimiento
15 donde se creó originalmente un ingrediente farmacéutico activo mediante procedimientos o
16 manipulaciones químicas, físicas, biológicas o de otro tipo. No incluye a las droguerías ni los
17 distribuidores al por mayor de medicamentos.

18 (ee) ...

19 ...

20 (nn) ...

21 (nn-1) Medicamento compuesto de alto riesgo -todo medicamento preparado mediante
22 la práctica de composición farmacéutica ("compounding") cuya administración sea sistémica

1 y que, por la naturaleza del producto, de sus ingredientes farmacéuticos activos o del proceso
2 de preparación, requiera controles avanzados de manufactura, esterilidad, estabilidad o
3 dosificación para evitar un riesgo significativo a la salud del paciente.

4 Se considerará que un medicamento compuesto es de alto riesgo cuando concurra
5 cualquiera de las siguientes circunstancias:

6 1. Preparaciones estériles. Todo medicamento compuesto estéril, incluyendo
7 aquellos preparados para administración inyectable, intratecal, intraocular,
8 intramuscular, subcutánea, intravenosa, implantable o por infusión.

9 2. Péptidos, biológicos u hormonas complejas. Medicamentos compuestos que
10 utilicen ingredientes farmacéuticos activos de naturaleza peptídica, proteica,
11 hormonal o biológica cuya seguridad y eficacia dependan de controles de
12 manufactura validados para preservar su integridad molecular, potencia,
13 esterilidad y estabilidad.

14 3. Dosificación crítica. Preparaciones inyectables o sistémicas que requieran
15 titulación, ajuste individualizado de dosis o concentraciones precisas, cuando la
16 variabilidad de concentración pueda afectar materialmente la seguridad del
17 paciente.

18 4. Formulaciones no aprobadas por FDA. Preparaciones que combinen uno o
19 más ingredientes farmacéuticos activos para producir una formulación distinta
20 a cualquier medicamento aprobado por la Administración Federal de Alimentos
21 y Medicamentos (FDA), para la cual no exista evidencia analítica validada de
22 compatibilidad química, estabilidad o precisión de dosificación.

1 5. Ambientes de esterilidad reforzada. Medicamentos compuestos cuya
 2 preparación requiera controles ambientales especializados de esterilidad, áreas
 3 clasificadas, campanas de flujo laminar, salas limpias ("clean rooms") u otros
 4 sistemas de aseguramiento microbiológico.

5 6. Preparación para inventario o uso en la oficina. Medicamentos compuestos
 6 preparados para inventario o uso en la oficina.

7 No se considerará "Medicamento Compuesto de Alto Riesgo" la preparación estéril
 8 realizada dentro de un hospital debidamente licenciado en Puerto Rico, cuando: sea realizada
 9 por una farmacia institucional bajo la supervisión de un farmacéutico licenciado; se administre
 10 exclusivamente a un paciente admitido o registrado; y responda a una orden médica válida,
 11 receta o protocolo terapéutico institucional. Esta exclusión aplicará únicamente a hospitales y
 12 no incluirá spas médicos, clínicas de bienestar, prácticas estéticas, clínicas ambulatorias
 13 comerciales, consultorios no institucionales ni establecimientos análogos, independientemente
 14 de su licenciamiento.

15 (oo) ...

16 ...

17 (mmm) ..."

18 ~~Artículo 2.- Propósito~~

19 ~~La Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de~~
 20 ~~Salud (SARAFS) y la Junta Examinadora de Farmacia enfrentan un problema sin~~
 21 ~~precedentes, y en aumento, de pacientes que reciben medicamentos preparados~~
 22 ~~ilegalmente, lo que representa riesgos significativos para la salud pública.~~

1 ~~El propósito de esta Ley es entender la naturaleza y escala de las actividades de~~
2 ~~preparación de medicamentos, incluyendo la supervisión actual de dichas~~
3 ~~actividades, para informar futuros esfuerzos que aseguren que los reguladores~~
4 ~~cuenten con los recursos necesarios para proteger a los pacientes.~~

5 Sección 3. - Se añade un nuevo inciso (f) al Artículo 5.04 de la Ley 247-2004, según
6 enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

7 “Artículo 5.04. — Medicamentos con requisitos especiales para su
8 dispensación.

9 (a) ...

10 ...

11 (e) ...

12 (f) Medicamento compuesto de alto riesgo

13 (i) Para la composición y dispensación de medicamentos compuestos de alto
14 riesgo, las farmacias y farmacias no residentes deberán solicitar y obtener del
15 Secretario una autorización especial para la dispensación de tales medicamentos
16 conforme a los requisitos que se establezcan mediante reglamento. Ninguna
17 farmacia, ni farmacia no residente, podrá dispensar medicamentos compuestos
18 de alto riesgo sin contar con dicha autorización especial vigente.

19 (ii) Toda farmacia o farmacia no residente que obtenga la autorización del
20 Secretario para la dispensación de medicamentos compuestos de alto riesgo, al
21 momento de su solicitud inicial y en cada renovación, deberá presentar ante el
22 Secretario, o la secretaría, división o junta que este designe, una declaración de

divulgación de la actividad de composición farmacéutica ("compounding") de medicamentos compuestos preparados y dispensados por dicha farmacia o farmacia no residente a pacientes localizados en Puerto Rico que debe al menos incluir:

1. Las categorías de medicamentos compuestos preparados, incluyendo si son estériles o no estériles;

2. La cantidad total de unidades de medicamentos compuestos preparadas durante el período de licencia anterior, clasificadas en preparaciones estériles y no estériles;

3. Una descripción de si los medicamentos compuestos se dispensan para administración en la farmacia, en un consultorio médico, dispensación directa al paciente o distribución a otras facilidades;

4. El número de pacientes atendidos con medicamentos compuestos durante el período del informe; y

5. Cualquier información adicional que la normativa exija razonablemente para evaluar la escala y el perfil de riesgo de las actividades de preparación de medicamentos compuestos.

6. Toda farmacia no residente deberá incluir en su declaración de divulgación de la actividad de composición farmacéutica ("compounding") de medicamentos compuestos preparados y dispensados a pacientes localizados en Puerto Rico:

- 1 a) Una copia del informe más reciente de inspección del estado
2 donde está físicamente operando; y
3 b) Una descripción de cualquier acción disciplinaria impuesta
4 por cualquier organismo regulador en contra de la farmacia o
5 farmacia no residente.
- 6 (iii) Ninguna farmacia, farmacia no residente o profesional de salud autorizado
7 podrá dispensar ni administrar un medicamento compuesto de alto riesgo sin
8 una receta válida emitida para un paciente específico. La receta deberá existir
9 previo a la preparación del medicamento, salvo en el contexto de una farmacia
10 institucional para administración inmediata a un paciente admitido o registrado
11 en un hospital.
- 12 (iv) Independientemente de la obtención de una autorización especial para la
13 dispensación de medicamentos compuestos de alto riesgo, se prohíbe:
- 14 1. la preparación anticipada para inventario general cuando el
15 medicamento compuesto de alto riesgo esté destinado a múltiples
16 pacientes no identificados previamente;
- 17 2. la dispensación de medicamentos compuestos de alto riesgo para
18 almacenamiento fuera de hospitales;
- 19 3. el envío directo a spas médicos, clínicas estéticas, centros de bienestar
20 o establecimientos no institucionales no autorizados por la Secretaría
21 Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) del
22 Departamento de Salud de Puerto Rico;

1 4. la distribución bajo programas de suscripción, membresía, paquetes
2 promocionales o modelos de dispensación automática;

3 5. la dispensación basada en protocolos estandarizados sin evaluación
4 clínica individualizada;

5 6. la sustitución o representación de un medicamento compuesto de alto
6 riesgo como equivalente terapéutico de un medicamento aprobado por la
7 Food and Drug Administration (FDA); y

8 7. la preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo que sean
9 esencialmente copias de un medicamento disponible comercialmente.

10 “Esencialmente copias de un medicamento disponible comercialmente”
11 significa preparaciones que incluyen el mismo ingrediente farmacéutico
12 activo que el medicamento disponible comercialmente, excepto que no
13 incluye ninguna preparación en la que se haya realizado un cambio para
14 un paciente individual identificado que produzca para ese paciente una
15 diferencia clínicamente significativa, según lo determine el médico
16 prescriptor y lo verifique y documente el farmacéutico, entre esa
17 preparación compuesta y un medicamento comercialmente disponible
18 comparable.

19 (v) Todo medicamento compuesto de alto riesgo deberá entregarse acompañado
20 de:

21 1. nombre y dirección de la farmacia preparadora;

22 2. nombre del farmacéutico responsable;

1 3. número de lote o identificación de preparación;

2 4. fecha de preparación y fecha de expiración clínica;

3 5. advertencia visible indicando que el producto es un medicamento

4 compuesto no aprobado por la Food and Drug Administration (FDA),

5 6. Información de contacto para reportar eventos adversos; y

6 7. Rotulación adecuada en cumplimiento con el Artículo 5.02 (d) de esta

7 Ley.

8 (vi) Las farmacias y farmacias no residentes solo podrán vender, transferir o

9 distribuir medicamentos compuestos de alto riesgo si se cumplen los siguientes

10 requisitos:

11 1. El ingrediente farmacéutico activo cumple con la Sección

12 503A(b)(1)(A) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y

13 Cosméticos (21 U.S.C. § 353a(b)(1)(A));

14 2. El ingrediente farmacéutico activo es un producto de grado

15 farmacéutico para uso humano;

16 3. El ingrediente farmacéutico activo está acompañada de una

17 certificación válida que contenga la identidad, pureza y potencia del

18 ingrediente farmacéutico activo, así como cualquier información

19 adicional que requiera el Secretario;

20 4. Todo ingrediente farmacéutico activo que no esté descrito en la

21 Farmacopea de los Estados Unidos (United States Pharmacopeia) o del

22 Formulario Nacional (National Formulary):

1 a. estará acompañado de documentación de pruebas adecuadas de
2 control de calidad realizadas por la facilidad que fabrica un
3 ingrediente farmacéutico activo, un fabricante subsiguiente o un
4 distribuidor al por mayor, que:

5 i. confirmen la identidad y el contenido del ingrediente
6 farmacéutico activo;

7 ii. informen, identifiquen, caractericen y cuantifiquen
8 cada impureza y solvente residual presente en el
9 ingrediente farmacéutico activo en una cantidad que
10 exceda una décima de uno por ciento (0.1%); y

11 iii. contengan cualquier información adicional que pueda
12 requerir el Secretario; o

13 b. antes de utilizar el ingrediente farmacéutico activo en la
14 preparación del medicamento compuesto de alto riesgo, la
15 persona dedicada a la preparación deberá obtener pruebas
16 adecuadas de control de calidad que contengan la información
17 especificada en el Artículo 5.04(f)(vi)(4)(a)(i)-(iii). La
18 información de control de calidad requerida por esta Artículo
19 5.04(f)(vi)(5) podrá incluirse en la certificación descrita en el
20 Artículo 5.04(f)(vi)(3).

1 (vii)(a) Toda farmacia y farmacia no residente deberá mantener documentación
2 verificable de que el ingrediente farmacéutico activo fue fabricado en una
3 facilidad que fabrica un ingrediente farmacéutico activo que:

4 1. está debidamente registrado ante la Food and Drug Administration
5 (FDA) bajo la Sección 510 del Food, Drug and Cosmetic Act (21 U.S.C.
6 360);

7 2. ha sido sometido a una inspección por parte de la Food and Drug
8 Administration (FDA) como establecimiento de medicamentos para uso
9 humano;

10 3. no está actualmente sujeto a una inspección no resuelta por parte de
11 la Food and Drug Administration (FDA) que fue clasificada como
12 “Acción Oficial Indicada” (“Official Action Indicated”);

13 4. Actualmente no está sujeto a ninguna Alerta de Importación emitida
14 por la Food and Drug Administration (FDA); y

15 5. no está actualmente sujeto a una Carta de Advertencia no resuelta de
16 la Food and Drug Administration (FDA).

17 La documentación requerida por este párrafo también debe incluir: País de
18 origen, dirección y número de identificación de establecimiento de la Food and
19 Drug Administration (FDA) de la Facilidad que fabrica un ingrediente
20 farmacéutico activo.

21 (b) Es ilegal que cualquier fabricante o mayorista venda, transfiera o distribuya
22 un ingrediente farmacéutico activo para su uso en la preparación de compuestos

1 sin proporcionar al comprador la certificación requerida en el Artículo
2 5.04(f)(vi)(3), la documentación de pruebas de control de calidad y la
3 verificación escrita descrita en el Artículo 5.04(f)(vi)(3) al Artículo
4 5.04(f)(vi)(4) y el Artículo 5.04(f)(viii)(a).

5 (viii) La preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo deberá cumplir
6 con el federal Food, Drug and Cosmetic Act, incluyendo las disposiciones de la
7 Sección 503A (21 U.S.C. 353a).

8 (ix) (a) Las farmacias y las farmacias no residentes que se dedican a la venta,
9 transferencia o distribución de medicamentos compuestos de alto riesgo deberán
10 mantener todos los registros relacionados con la adquisición, el examen y la
11 prueba del ingrediente farmacéutico activo durante no menos de dos (2) años
12 después de la fecha de vencimiento del último lote de medicamento compuesto
13 de alto riesgo que contenga el ingrediente farmacéutico activo y, a solicitud del
14 Secretario, deberán proporcionar dichos registros dentro de un tiempo razonable
15 según lo determine el Secretario en función de las circunstancias de la solicitud.

16 (b) El Secretario o la secretaría, división o junta que este designe, tendrá la
17 facultad de requerir a cualquier farmacia o farmacia no residente que venda,
18 transfiera o distribuya medicamentos compuestos de alto riesgo, así como
19 cualquier Facilidad que fabrique un ingrediente farmacéutico activo, fabricante
20 posterior o Distribuidor al por mayor de medicamentos que venda, transfiera o
21 distribuya un ingrediente farmacéutico activo para su uso en la preparación de
22 compuestos, la documentación, certificaciones, autorizaciones o licencias

1 necesarias para verificar el cumplimiento con los requisitos del Artículo
2 5.04(f)(v) a Artículo 5.04(f)(viii). Negarse a proveer documentación requerida
3 por el Secretario o la secretaría, división o junta que este designe para para
4 verificar el cumplimiento con los requisitos del Artículo 5.04(f)(v) a Artículo
5 5.04(f)(viii) constituirá una violación a esta Ley.

6 (c) El Secretario está autorizado a promulgar las reglas que sean necesarias para
7 implementar esta Ley.

8 (x)(a) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(vi), 5.04(f)(vii) y 5.04(f)(viii) darán lugar
9 a:

10 1. una multa de mil dólares (\$1,000) por cada dosis del medicamento compuesto
11 de alto riesgo vendida, transferida o distribuida; y
12 2. revocación de la licencia de Distribuidor al por mayor de medicamentos o de
13 Droguería y cualquier otra licencia, certificado, registro o autorización emitida
14 por el Secretario de Salud.

15 (b) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(vii)(b) de esta Ley darán lugar a:

16 1. una multa de mil dólares (\$1,000) por cada miligramo del ingrediente
17 farmacéutico activo distribuido ilegalmente; y
18 2. revocación de la licencia de Distribuidor al por mayor de medicamentos o de
19 Droguería.

20 (c) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(ix) resultarán en una multa de \$5,000 y
21 darán lugar a la revocación de la licencia correspondiente.

(xi) Todo farmacéutico que conozca de un evento adverso asociado a un medicamento compuesto de alto riesgo dispensado o administrado a un paciente localizado en Puerto Rico deberá notificarlo al Departamento de Salud dentro de diez (10) días laborables desde que advenga en conocimiento, en caso de un evento adverso grave, deberá notificarlo al Departamento de Salud dentro de cinco (5) días laborables desde que advenga en conocimiento."

Artículo 3.- Definiciones

~~(a) Informe bianual: Reporte que debe ser publicado dos veces al año por las juntas reguladoras, conteniendo datos sobre la supervisión de la preparación de medicamentos, conforme a los requisitos de esta Ley.~~

~~(b) Junta Examinadora de Farmacia: La entidad reguladora establecida bajo la Ley Núm. 247-2004 de Puerto Rico encargada de supervisar la práctica de la farmacia, incluyendo la preparación, distribución y dispensación de medicamentos.~~

~~(c) Medicamentos Compuestos: La práctica de combinar, mezclar o alterar ingredientes para crear un medicamento adaptado a las necesidades de un paciente, realizada por farmacias, instalaciones de subcontratación o profesionales autorizados, conforme a las regulaciones aplicables.~~

~~(d) Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAES): Dependencia del Departamento de Salud de Puerto Rico encargada de inspeccionar y licenciar facilidades de salud para garantizar que cumplan con las leyes y estándares de calidad. Reglamenta y supervisa~~

1 ~~hospitales, farmacias, centros de cirugía ambulatoria y otros servicios de~~
2 ~~salud en la isla.~~

3 ~~(e) Spa médico o clínica de bienestar: Establecimiento que ofrece servicios~~
4 ~~médicos o de bienestar, incluyendo la administración o dispensación de~~
5 ~~medicamentos preparados, pero que no está licenciado como hospital o~~
6 ~~centro quirúrgico ambulatorio.~~

7 Sección 4.- Se añade un nuevo Artículo 5.11-A a la Ley 247-2004, según enmendada,
8 conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

9 “Artículo 5.11. – Farmacia.

10 (a)...

11 ...

12 (i) ...

13 Artículo 5.11-A. – Farmacia no residente con dispensación a paciente localizado en
14 Puerto Rico.

15 (a) Ninguna farmacia no residente podrá dispensar, enviar, entregar, causar la entrega,
16 facturar o de cualquier forma proveer medicamentos a pacientes localizados en Puerto Rico sin
17 previamente registrarse ante la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública
18 (SARSP) del Departamento de Salud de Puerto Rico como farmacia no residente y recibir un
19 certificado de registro de farmacia no residente.

20 (b) Para configurar un registro válido y obtener un certificado de registro de farmacia
21 no residente la farmacia no residente deberá presentar:

1 1. Una licencia vigente y en buen estado en la jurisdicción donde ubique
2 físicamente;

3 2. Aprobación del National Association of Boards of Pharmacy Digital
4 Pharmacy Accreditation Program;

5 3. Identificar un farmacéutico responsable de cumplimiento regulatorio para
6 pacientes localizados en Puerto Rico, quien fungirá como punto de contacto
7 principal ante el Departamento de Salud y responderá ante cualquier evento de
8 incumplimiento con esta Ley. Un farmacéutico no podrá ser designado un
9 farmacéutico responsable para más de una farmacia no residente.

10 4. Designar un agente representante en Puerto Rico autorizado a recibir
11 notificaciones administrativas y judiciales;

12 5. Presentar una declaración jurada certificando y haciendo constar que una vez
13 registrada la farmacia no residente cumplirá con:

14 (i) someter certificaciones de cumplimiento con estándares aplicables de
15 preparación y manejo de medicamentos;

16 (ii) Mantener y proveer, a requerimiento del Departamento de Salud de
17 Puerto Rico documentación verificable relacionada con recetas,
18 preparación, dispensación y envío de medicamentos a pacientes
19 localizados en Puerto Rico;

20 (iii) Notificar al Departamento de Salud de Puerto Rico cualquier evento
21 adverso con medicamentos dispensados o administrados a pacientes
22 localizados en Puerto Rico dentro de un término no mayor de diez (10)

días laborables o en casos de evento adverso grave en cinco (5) días laborables contados en ambas instancias desde que advenga en conocimiento o razonablemente debió haber conocido de dicho evento.

(iv) Cumplir con los requisitos de reporte establecidos en esta Ley.

6. Sufragar los derechos establecidos en el Artículo 5.16 de esta Ley.

(c) Requisitos de Reporte. Toda farmacia no residente registrada ante la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) del Departamento de Salud de Puerto Rico, que a su vez haya obtenido la autorización de medicamentos compuestos de alto riesgo, deberá al momento del registro y renovación presentar una declaración de divulgación de la actividad de composición farmacéutica ("compounding") de medicamentos compuestos preparados y dispensados a pacientes localizados en Puerto Rico de conformidad con el Artículo 5.04(f) de esta Ley.

(d) Al cumplir con los parámetros de este este Artículo, la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) emitirá un Certificado de Registro de farmacia no residente. El Certificado de Registro de farmacia no residente será válido por un (1) año. El mismo debe ser renovado anualmente mediante presentación de los documentos requeridos en este artículo al menos cuarenta y cinco (45) días antes de su vencimiento.

(e) Ningún plan médico, aseguradora, administrador de beneficios de farmacia (PBM), hospital, clínica, farmacia o proveedor de salud establecido en Puerto Rico y regulado por las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico podrá pagar, procesar, adjudicar o reembolsar reclamaciones por medicamentos dispensados a pacientes localizados en Puerto Rico por farmacias no residentes no registradas conforme a esta Ley.

1 (f) Ningún profesional de la salud autorizado a ejercer en Puerto Rico y sujeto a las
2 leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico podrá ordenar, coordinar la dispensación ni
3 administrar medicamentos a través de una farmacia no residente no registrada.

4 (g) El Secretario, en coordinación o por vía de la Secretaría Auxiliar para la Regulación
5 de la Salud Pública (SARSP), está facultado para:

6 1. Emitir órdenes administrativas de cese y desista respecto a la dispensación de
7 medicamentos hacia pacientes localizados en Puerto Rico;

8 2. notificar a agencias regulatorias estatales o federales;

9 3. requerir a planes médicos o PBMs la denegación de reclamaciones
10 provenientes de farmacias no residente son registradas; y

11 4. establecer multas administrativas conforme a la Ley 38-2017 conocida como
12 la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.

13 (h) El Secretario, en coordinación o por vía de la Secretaría Auxiliar para la Regulación
14 de la Salud Pública (SARSP), deberá:

15 1. Aprobar los reglamentos que sean necesarios para hacer cumplir lo dispuesto
16 en este artículo.

17 2. Publicar el registro de farmacias no residentes.

18 (i) Nada en este artículo autoriza a la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud
19 Pública (SARSP) ni al Departamento de Salud de Puerto Rico a regular las operaciones
20 internas de farmacias no residentes. La autoridad conferida se limita exclusivamente a la
21 protección de la salud pública respecto a la dispensación y administración de medicamentos a
22 pacientes localizados en Puerto Rico.

1 (j) Este artículo se interpretará como una medida de salud pública dirigida
2 exclusivamente a regular la dispensación de medicamentos a pacientes localizados en Puerto
3 Rico y no como una regulación extraterritorial del ejercicio de la profesión de la farmacia fuera
4 de Puerto Rico.”

5 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 5.16 de la Ley 247-2004, según enmendada,
6 conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

7 “Artículo 5.16. – Vigencia y derechos de licencias, certificados, registros y
8 autorizaciones.

9 (a) Las licencias y registros requeridas en este Capítulo, salvo lo relacionado al
10 Registro de Medicamentos y al Certificado de Registro de Farmacia No Residente, tendrán
11 dos (2) años de vigencia desde la fecha de su expedición y se renovarán en forma
12 escalonada, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos que se
13 establezcan por reglamento y el pago de los correspondientes derechos; con excepción
14 de los certificados de registros de medicamentos y/o productos biológicos para
15 oficinas médicas, dentales y podiátricas, y para ensayos clínicos en instituciones de
16 educación superior u oficinas médicas, que tendrán tres (3) años de vigencia, y se
17 obtendrán mediante radicación del registro según la fecha de renovación de licencia
18 profesional del médico, dentista o podiatra, cuando corresponda. Además, será deber
19 del Departamento de Salud, en lo posible y mientras los recursos fiscales lo permitan,
20 el establecer los procedimientos para poder radicar y expedir mediante su página
21 electrónica gubernamental (Internet) la solicitud para obtener las licencias requeridas
22 en este Capítulo o el Certificado de Registro Trienal de Medicamentos y/o Productos

1 Biológicos en Oficina Médica, y Certificado de Registro Trienal de Medicamentos y/o
 2 Biológicos para Ensayos Clínicos en Institución de Educación Superior y el registro de
 3 farmacia no residente .

4 (b) ...

5 (c) Toda persona que opere más de un establecimiento de los definidos en esta
 6 Ley, deberá solicitar y obtener una licencia, certificado, registro o autorización
 7 separada para cada uno de los establecimientos.

8 (d) Las licencias, certificados, registros y autorizaciones no serán transferibles.

9 (e) La licencia, certificado, registro o autorización se expedirá a nombre del
 10 dueño o razón comercial que la solicite y aplicará solamente al establecimiento en la
 11 localización que se indique en la faz de la misma. Además, especificará el tipo de
 12 establecimiento para el cual se otorga según definidos en esta Ley.

13 (f) Las licencias, certificados, registros y autorizaciones que se enumeran a
 14 continuación pagarán los siguientes derechos que estarán vigentes desde la fecha de
 15 aprobación de esta Ley hasta que el Secretario, mediante reglamento, establezca otros
 16 derechos:

17 1. ...

18 ...

19 17...

20 18. Certificado de Registro de farmacia no residente - \$500.

21 (g) ...

1 (h) Los ingresos que se recauden por estos conceptos serán depositados en el
 2 Fondo de Salud creado bajo las disposiciones del Artículo 11-A de la Ley Núm. 26 de
 3 13 de noviembre de 1975, según enmendada, para uso exclusivo de la División de
 4 Farmacia, en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones en el Capítulo V
 5 de esta Ley; con excepción de los fondos que se recauden del Certificado de Registro de
 6 Farmacia no residente. Los recaudos del Certificado de Registro de Farmacia no residente
 7 deberán ser transferidos al Departamento de Salud para fortalecer las capacidades de la
 8 Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP)."

9 Sección 6 Artículo 4.- Se añade un nuevo Artículo 5.18 a la Ley 247-2004, según
 10 enmendada, conocida como "Ley de Farmacia de Puerto Rico", para que lea como sigue:

11 Artículo 5.18. – Informe sobre Supervisión de la Preparación de Medicamentos
 12 Compuestos.

13 La Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP)
 14 Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), junto con la Oficina
 15 de Planificación y Desarrollo, o cualquier otra secretaría, unidad, oficina o dependencia que el
 16 Secretario del Departamento de Salud determine, Junta Examinadora de Farmacia y el
 17 Departamento de Justicia, desarrollará y publicará un informe bianual sobre la
 18 supervisión de la preparación de medicamentos y los riesgos compuestos asociados
 19 con dichas prácticas. Dicho informe incluirá los siguientes elementos:

20 (a) El número de autorizaciones y tipo de licencias emitidas por el Secretario, o la
 21 secretaría, división o junta que este designe, la Secretaría Auxiliar para
 22 Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) y la Junta

~~Examinadora de Farmacia según aplique, bajo las cuales el titular de la licencia pueda realizar la preparación para la dispensación~~ de medicamentos compuestos de alto riesgo, incluyendo ~~un desglose de licencias residentes y no residentes, y licencias~~ autorizaciones para la dispensación ~~preparación~~ de medicamentos ~~estéril compuestos estériles para uso parenteral o cualesquiera otros medicamentos que requieran técnicas asépticas especiales.~~

(b) El número de certificados de registro de farmacias no residentes emitidos por la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP).

~~(b)~~ (c) El número de instalaciones y prácticas licenciadas, autorizadas o registradas que han sido inspeccionadas en el último año y en los últimos tres años, desglosado por tipo de licencia, autorización o registro.

~~(e)~~ (d) El número de inspecciones realizadas a instalaciones y prácticas involucradas en la preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo, o en el manejo, almacenamiento, administración, dispensación, distribución u otro uso de medicamentos preparados en el ámbito minorista o ambulatorio, incluyendo farmacias y farmacias no residentes ~~503A, instalaciones de subcontratación 503B y spas médicos,~~ pero excluyendo instalaciones de salud licenciadas como hospitales o centros quirúrgicos ambulatorios.

~~(d)~~ (e) Una descripción de la naturaleza y gravedad de cualquier deficiencia o posible violación observada durante las inspecciones o reportadas por farmacéuticos de farmacias autorizadas para la dispensación de medicamentos compuestos de alto riesgo o farmacias no residentes.

(e) ~~(f)~~ El número de investigaciones abiertas por ~~cada entidad reguladora, el~~
~~Departamento de Salud,~~ o cualquier otra agencia estatal a la que se le haya referido
una investigación, relacionadas con la preparación de medicamentos.

~~(f)~~ (g) El número y tipo de acciones disciplinarias tomadas por ~~el Departamento~~
~~de Salud~~~~cada entidad reguladora,~~ o cualquier otra agencia estatal a la que se le
haya referido una investigación, relacionadas con la preparación de medicamentos
 compuestos.

~~(g) El número y tipo de acciones disciplinarias tomadas por cada entidad~~
~~reguladora, o cualquier otra agencia estatal, relacionadas con la~~
~~comercialización, publicidad o promoción engañosa o indebida de~~
~~medicamentos compuestos, servicios de telemedicina o servicios de telesalud.~~

(h) Una evaluación de los recursos humanos y materiales de la ~~Junta de~~
~~Farmacia, así como de~~ Secretaría Auxiliar para para la Regulación de la Salud
Pública (SARSP) Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud, en
 relación con la escala estimada de la preparación de medicamentos compuestos
 de alto riesgo.

(i) Un análisis de la naturaleza y gravedad de los riesgos emergentes
 relacionados con la preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo, y
 la distribución, comercialización y venta de medicamentos compuestos.

El primer informe se publicará a más tardar el 1 de ~~marzo~~ ~~septiembre~~ de 2027
~~2026~~, con datos correspondientes del 1 de ~~julio~~ ~~enero~~ de 2026 al 31 de diciembre ~~30 de~~
~~junio~~ de 2026. Posteriormente, los informes se publicarán dos veces al año, a más

1 tardar el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año, conteniendo datos de los seis
2 meses anteriores, respectivamente.

3 ~~Artículo 5.- Deber de Coordinación.~~

4 ~~La Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de~~
5 ~~Salud (SARAFS) lidera la coordinación con la Junta Examinadora de Farmacia, el~~
6 ~~Departamento de Justicia, para garantizar la recopilación precisa y oportuna de los~~
7 ~~datos requeridos para los informes bianuales. La Junta Examinadora de Farmacia~~
8 ~~proporcionará la información relevante dentro de sus jurisdicciones en un plazo no~~
9 ~~mayor a 30 días naturales tras la solicitud de SARAFS.~~

10 ~~Artículo 6.- Acceso Público.~~

11 Los informes bianuales serán publicados en la página electrónica oficial ~~los sitios~~
12 ~~web oficiales~~ de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) o
13 del Departamento de Salud de Puerto Rico ~~para Reglamentación y Acreditación de~~
14 ~~Facilidades de Salud (SARAFS) y de la Junta Examinadora de Farmacia~~, además de
15 estar disponibles para consulta pública sin costo alguno. ~~Las entidades notificarán~~ La
16 Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) notificará al público
17 sobre la publicación de cada informe mediante comunicados oficiales.

18 ~~Artículo 7.- Prohibición de Costos Adicionales.~~

19 Se prohíbe imponer cualquier cargo monetario a los ciudadanos, profesionales
20 de la salud o instalaciones licenciadas para el cumplimiento ~~de las disposiciones de la~~
21 divulgación del informe bianual establecido en de esta Ley Sección.

22 Sección 7.- Reglamentación

1 El Secretario del Departamento de Salud está autorizado y deberá, dentro de ciento
2 ochenta (180) días de aprobada esta Ley, aprobar o enmendar los reglamentos que sean
3 necesarios para el fiel cumplimiento de esta Ley.

4 Sección ~~Artículo~~ 8.- Cláusula de separabilidad.

5 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada
6 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la
7 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de
8 dictamen adverso.

9 Sección ~~Artículo~~ 9.- Vigencia.

10 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.